

ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ ИДЕЙ 2.0

ДИСКУССИЯ · 26 АВГУСТА · 14:00–15:30

Организация питания: опыт реализации проектов

Шесть вопросов — от права проживающего до нормирования цен. Два дома одного учредителя, разные маршруты к выбору.

Чистяков Е. В. · ДСО «Серафимовский»

Нурбаев Т. А. · ДСО «Тесовый берег»

Площадка № 2 — ДСО «Тесовый берег» · материал — раздел 17.12 доклада «Не просто накормить»

6

вопросов · 90 минут

17.12

раздел доклада — ответы

2

дома · один учредитель

Как устроен разговор: вопрос → позиция → доказательство

Два эксперта

Чистяков Е. В. и Нурбаев Т. А. — два дома одного учредителя. По каждому вопросу — два опыта, иногда два ответа: это ценность, а не противоречие.

Шесть вопросов

От «кто выбирает форму питания» до «качество против нормирования цен». На каждый — 10–12 минут: позиция, практика, данные, ответы зала.

Зал — источник опыта

Вопросы построены так, чтобы у зала был собственный опыт. Голосуем руками, расхождения фиксируем — разбор в конце каждого вопроса.

Правило дискуссии: каждое утверждение — «принцип + метод проверки + чужой измеренный факт». Ни одно не требует веры: всё проверяется замером, документом или первоисточником.

Где данных нет — говорим об этом прямо: честный пробел тоже позиция.

Кто выбирает форму питания — проживающий в социальном доме или его «хозяин»?

ПОЗИЦИЯ

Хозяин еды — проживающий. Закон не знает «хозяина»: он знает получателя услуги с правом на учёт индивидуальных потребностей — ст. 9 и 16 442-ФЗ, ст. 37/43 закона № 3185-1. Выбор — реализация субъективного права, а не назначение лечения (раздел 17.12 доклада).

МЕТОД ПРОВЕРКИ

Три вопроса к вчерашнему дню: зафиксирован ли вчерашний выбор? Был ли второй вариант на линии? Есть ли житель, получивший не то, что выбрал бы по умолчанию?

ФАКТ

Российские практики ступеней 1–2 работают в обычных учреждениях без спецбюджетов. Вопрос «хозяин или проживающий» решается процедурой, а не деньгами.

Зал: поднимите руку — в чьём учреждении выбор реально фиксируется вчерашним днём, а не положением? А у кого «выбор» существует только в документе?

Разбор — разделы 8.7, 17.12 и 22 доклада.

Как формировать меню в условиях жёстких нормативно-правовых и финансовых ограничений?

1

Норма — основание, а не потолок: нормы 520н и таблицы замен задают сырьевую структуру; меню утверждается приказом директора

2

Пары эквивалентов: второй вариант — из той же заготовки; сырьё перераспределяется, а не добавляется

3

Объёмы по журналу заказа: заказ накануне, старт 50/50, пересчёт раз в две недели

4

Замер — арбитр: семь дней до старта и через 90 дней дают вашу цифру стоимости

Факт: Болотнинский и Успенский ПНИ стартовали в действующих лимитах. Ориентиры стоимости: Алтайский край — 422 руб./чел./день (2025), тарифы на соцслужбы СПб — распоряжение 1366-р; нижняя граница — продуктовая корзина ≈270 руб./день (Росстат, 2026).

Зал: кто знает свою сырьевую строку — рублей на жителя в день — за пять минут деления? А кто знает норматив своего региона на 2026 год?

Если ни того ни другого — это и есть первый шаг. Разбор — разделы 17.12 (вопрос 2), 29.3 и 24 доклада.

Должно ли быть питание в социальных домах «лечебным»?

ПОЗИЦИЯ

Основное питание — социально-бытовая услуга (ст. 24 442-ФЗ), не лечебная. Диетическое (лечебное) — по назначению врача, поимённо, со сроком пересмотра: ст. 39 323-ФЗ относит лечебное питание к компонентам лечебного процесса. Ключ — медицинская лицензия: есть лицензия — приказы Минздрава (330н, 395н) обязательны; нет — диетический стол назначает врач, но питание учреждения «лечебным» не становится (раздел 17.12 доклада).

РИСК «СТОЛА НА ВСЕХ»

«Диабетический стол» без назначений — ограничение без показаний; «лечебное меню» без лицензии — введение в заблуждение (ст. 14.7 КоАП, при обстоятельствах — ст. 238 УК).

МЕТОД ПРОВЕРКИ

В учреждении есть поимённый список диетического питания с назначениями, датами и сроками пересмотра — или его нет. «Стол на всех» назначением не является.

Зал: есть ли в ваших домах «диетические столы» без врачебных назначений? У кого список диетпитания поимённый и с датами пересмотра?

Разбор — разделы 17.12 (вопрос 3) и 17.5 доклада.

Как совместить «лечебное питание» и «вариативное меню», не ограничивая право выбора?

ПОЗИЦИЯ

Диета — ограничение множества, а не сжатие до одного элемента: вариативность внутри назначенной диеты. Врач определяет «что показано», житель выбирает «что из показанного».

Двойная раскладка: 2 основных + 2 диетических варианта (Успенский ПНИ, Серафимовский)

Совмещённые пары: основная пара + диетическая пара на одной линии — апробация Тесового берега (Нурбаев, 2025)

День через день: вариативность в дни, когда диета охватывает менее 30 % жителей — стартовая модель

Шведский стол с диетической зоной: отдельная витрина, отдельный повар, маркировка «без сахара / протёртое»

Алгоритм: список диет с назначениями → пары эквивалентов на каждую диету (макронутриенты $\pm 5\%$) → согласование с врачом → визуальное меню «выберите один из четырёх» → журнал выбора.

Нельзя: навязывать диету без показаний · снимать диету по просьбе жителя при назначении · подменять диетическое блюдо без фиксации.

Как соблюсти баланс права выбора недееспособного проживающего и медицинских показаний?

ПОЗИЦИЯ

Недееспособность отменяет сделки, а не волю (ст. 29 ГК): выбор блюда — не сделка. Мнение недееспособного учитывается, для неговорящих — четыре канала воли: слово, показ, наблюдение, пищевая биография. Опекун — помощник в интерпретации, а не замена воли.

ТРИ СЦЕНАРИЯ (раздел 17.12): А — недееспособный без показаний: воля реализуется, опекун помогает интерпретировать · Б — с показаниями: врач назначает, опекун уведомляется в тот же день, отказ опекуна фиксируется документально · В — клинический случай (голодовка, пика): комиссия в тот же день, голодовка/отказ от воды 24+ часов — повод для комиссии, а не ожидания воли.

Формула баланса: врач определяет, что показано · житель выбирает, что из показанного · расхождение документируется и разбирается комиссией с участием опекуна.

· Принудительное кормление не существует ни в какой форме (раздел 12.4) · лечебное питание без согласия опекуна — только по принудительным мерам (ст. 11 3185-1)

Как совместить качество продуктов и нормирование цен при планировании бюджета?

ПОЗИЦИЯ

Нормативная цена — верхняя граница расходов; качество — нижняя граница приемлемости товара. Задача решается не «выбором», а структурой закупочной процедуры: НМЦК по анализу рынка (ст. 22 44-ФЗ), качество в ТЗ (ст. 33–34), контроль заказчика (ст. 94), расторжение (ст. 95 + РНП). Автономные дома работают по 223-ФЗ.

Входной контроль

Вес, температура, документы партии, лабораторная выборка — по письму Комитета по соцполитике
СПб (ежедневный мониторинг)

Качество в ТЗ

«Молоко по ГОСТ 31450-2013, срок ≥ 7 суток, t 2–6 °C» — планка до торгов, а не после

Фиксация → претензия

Акт → требование со сроком → претензия → расторжение + РНП; судебная практика требует строгой процедуры

Экономика без иллюзий

Сырьё — меньшая часть полной стоимости; сокращение сырья — самая вредная «экономия»; сезонность и совместные закупки — –5–15 %

Ориентиры стоимости (раздел 17.12): Алтайский край — 422 руб./день (2025) · СПб: лечебное питание в ЛПУ — 655–683 руб./день, тарифы на соцуслуги — 1366-р · нижняя граница — продуктовая корзина ≈ 270 руб./день (2026).

Факт (авторский опыт): Серафимовский, 2026 — системные срывы питания поставщиком, фиксация нарушений, правовое обоснование одностороннего отказа по контракту (внутренние документы; публикации нет).

Зал: у кого есть опыт расторжения контракта на питание? Что показала практика?

Серафимовский и Тесовый берег: что общего и что разное

Общее — то, что нельзя обойти:

Один учредитель, один СанПиН (с 01.09.2026 — 4282-26), одни нормы Минтруда; оба дома — автономные, закупки по 223-ФЗ

Один контингент: люди с психическими нарушениями, часть — недееспособны

Один вызов: качество при нормированной цене и жёсткой проверке

Одна цель: еда как ежедневный тест на уважение

Разное — то, что даёт материал:

Модели совмещения: Серафимовский — диетстолы внутри основного питания; Тесовый берег — совмещённые пары на одной линии

Масштаб, профиль отделений, возраст контингента — разные пропорции

Хронология проектов: кто-то стартовал раньше — у кого-то свежий старт

Опыт сбоев: у кого-то есть «где ломалось» — самый ценный материал

Вопрос залу: в каком месте этого списка ваш дом? Поднимите руку — своя кухня или аутсорсинг; стартовали или только планируете; есть ли уже «где ломалось»?

Шесть вопросов — один ответ: право на выбор организуется, а не декларируется

Позиция

Хозяин еды — проживающий. Дом — организатор его права, а не замена его воли. Лечебное питание — по назначению, выбор — внутри нормы и внутри диеты.

Метод

Замер → документ → пара на линии → панель чисел. Качество при нормированной цене — процедура входного контроля, а не надежда.

Факт

Четыре российских кейса и один регион · четыре модели совмещения диеты и выбора · письмо учредителя об усилении контроля за поставщиками.

Первый шаг после дискуссии — тот же, что после доклада: семь дней замера. Отходы, отказы, время раздачи, фактический вес порций от поставщика.

Раздел 17.12 доклада — у каждого вопроса есть глубокий ответ с источниками; раздатка — на столе.

Спасибо. Чистяков Е. В. · Нурбаев Т. А. — вопросы из зала и контакты.